Université de Bejaia
Faculté de médecine
Enseignement de 3ème année médecine
sémiologie 2021-2022

La Sémiologie Pondérale

Dr: M.TEBBANI

Introduction

Le corps comprend 4 secteurs principaux :

1. — Le tissu de soutien (squelette, tissu conjonctif)
2. — Le liquide extracellulaire
3. — La masse active (muscles, parenchymes, cellules)
4. — Le tissu adipeux : qui représente 15 à 20 % du poids corporel chez l'homme et 25 à 30 % chez la femme, c’est l'essentiel des réserves énergétiques.

- La somme de ces secteurs représente le poids corporel global.
- Des variations portant sur chacun de ces secteurs peuvent modifier le poids corporel
- Le poids normal ou poids idéal est déterminé par rapport à la taille, il est également fonction de l'âge

Chez le nourrisson et l’enfant

- Il existe des courbes de poids établies en fonction de la taille et de l'âge

- Un nouveau-né à terme pèse 3,500 kg et mesure 50 cm; approximativement il double son poids de naissance à 5 mois, il le triple à 1 an.

Chez l'adulte:

Le poids normal peut être déterminé de plusieurs manières :

1. Son appréciation selon les recommandations de l'OMS par le calcul de l'indice de masse corporelle = IMC

IMC = poids (Kg) / taille (m)2

2. Le poids idéal peut aussi être calculé grâce à **la formule de Lorentz :** N'est plus utilisée

- Poids (Kg) = Taille (cm) – 100-(Taille –150) / 4 chez l'homme

  =Taille (cm) – 100-(Taille –150) / 2 (chez la femme)

- Il faut ajouter 1 ou 2 kg par décennie au-delà de 20 ans

3. Approximativement, le poids est représenté par le nombre de centimètres au dessus du mètre.

- Exemple : Pour une taille de **1,70** m, le poids normal serait d'environ **70** kg.

La pathologie pondérale

Les variations du secteur hydrique:

1. La déshydratation
2. Les œdèmes

Les variations de la masse grasse:

1. L’ obésité
2. L’ amaigrissement
3. La maigreur

L’obésité

introduction

- L’obésité se définit comme une augmentation de la masse graisseuse, d’au moins 20 % du poids normal.

- Déséquilibre entre les apports et les dépenses d’énergie

- Prédominance féminine

- Prévalence augmente avec l’âge

Étude sémiologique

I- l’interrogatoire:

II-L’esxamen clinique

III-La recherche étiologique

L’interrogatoire:

doit préciser:

1. Les Modalités de prise de poids
2. Les circonstances
3. Les antécédents familiaux
4. L’enquête alimentaire
5. Les dépense énergétiques
6. Le profil psychologique

1-Les modalités de prise de poids

Il est important de rechercher:

- Le poids à la naissance
- Le poids maximum, le poids minimum
- Âge de début de prise de poids
- Les tailles vestimentaires successives
- Mode d’installation rapide en quelques mois
- Ou progressive en quelques années

2-Les circonstances de prise de poids

- Modification du statut hormonal : puberté, grossesse ou ménopause.
- Choc émotionnel ou affectif : (dépression)
- Changement d’environnement relationnel, familial (mariage, divorce, perte d’un emploi)
- Arrêt de tabac
- Baisse ou arrêt de l’activité physique
- Une intervention chirurgicale
- Une prise médicamenteuse : corticoïdes, œstrogène, antidépresseurs
- Pathologie endocrinienne : hypothyroïdie, cushing.

3-Les antécédents familiaux

- L’obésité est souvent considérée comme familiale

- L’interrogatoire doit rechercher les ATCD familiaux:
  - D’obésité
  - De maladies métaboliques (diabète sucré, dyslipidémie)
  - De pathologies vasculaires (HTA,IDM, angor, artérite)

  - Déterminer un arbre généalogique qui permettra d’évaluer les facteurs génétiques :
    - Lorsque les deux parents sont obèses: 60 à 80 % des enfants sont obèses
    - Lorsqu’un seul parent est obèse, 40 % des enfants obèses

4-L’enquête alimentaire

1-Les troubles quantitatif:

- 20 % des cas de troubles du comportement alimentaire
- Essentiellement représentés par la polyphagie: Se définit comme l’augmentation de la quantité d’aliments ingérés, quelque soit leur nature, généralement aux moments des repas

- Peut être « normale » chez certains individus: le seuil de satiété augmenté

- Dans certaines situations pathologiques
- C’est le témoignage d’une augmentation des besoins énergétiques de l’organisme (DTI)
- La particularité de cette polyphagie est de ne pas s’accompagner d’une prise de poids, bien au contraire on assiste à l’installation d’un amaigrissement de plus en plus important

4-L’enquête alimentaire

1-Les troubles qualitatifs:

- Fréquents

- 2/3 des troubles du comportement alimentaire

- Ces troubles qualitatifs sont :

  a. - la compulsion alimentaire

  b. - le grignotage

  c. - la boulimie.

4-L’enquête alimentaire

a. **<u>la compulsion alimentaire:</u>**

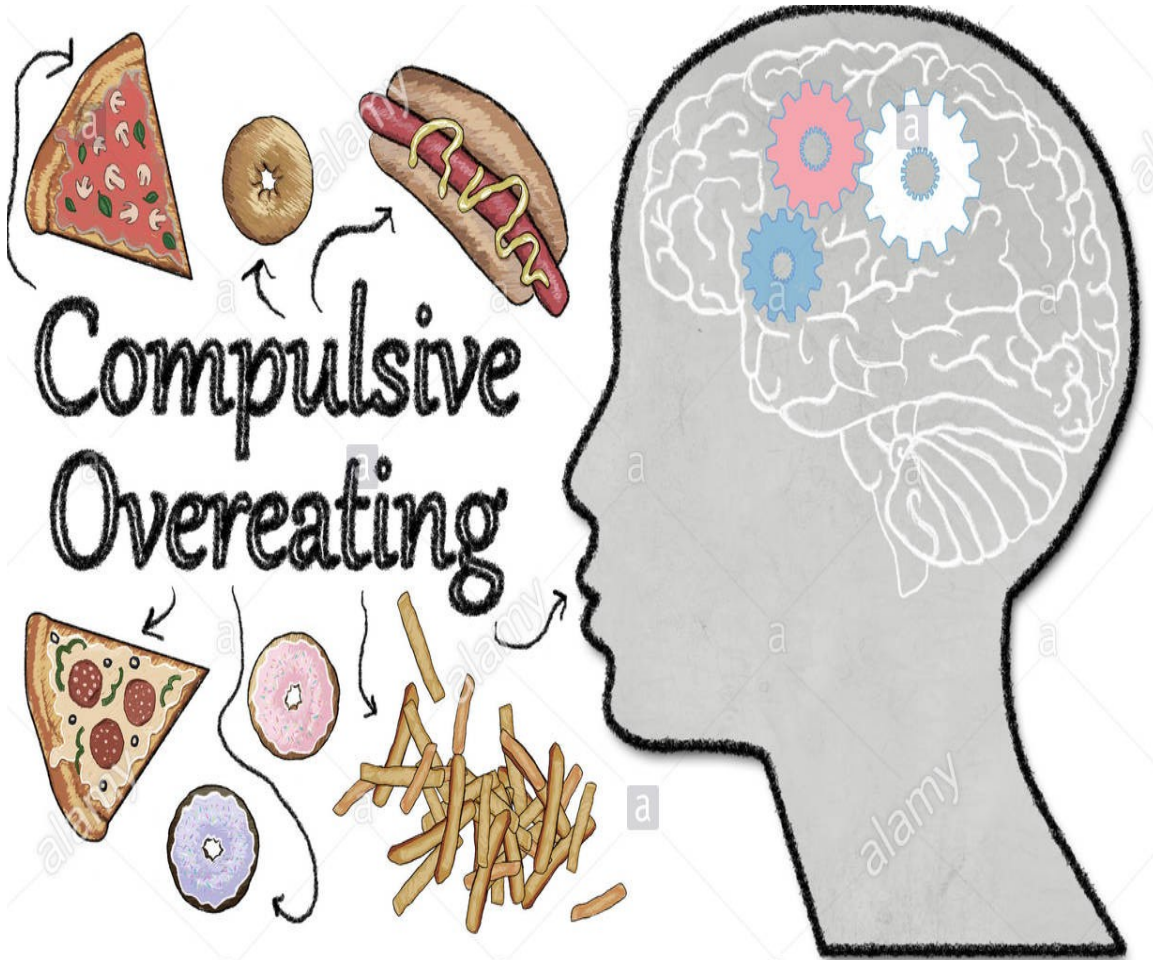
- C’est une sensation d’impulsion ou envie soudaine de consommer un aliment particulier, le plus souvent sucré

- Considéré comme un comportement réflexe de défense, généralement contre l’angoisse et l’anxiété.

- Exemples :

a. L’envie chez la femme enceinte

b. L’envie de manger un gâteau, de la confiture, etc…, le soir avant de dormir



4-L’enquête alimentaire

b. Le Grignotage:

- C’est le fait de manger sans arrêt de petites quantités d’aliments particuliers

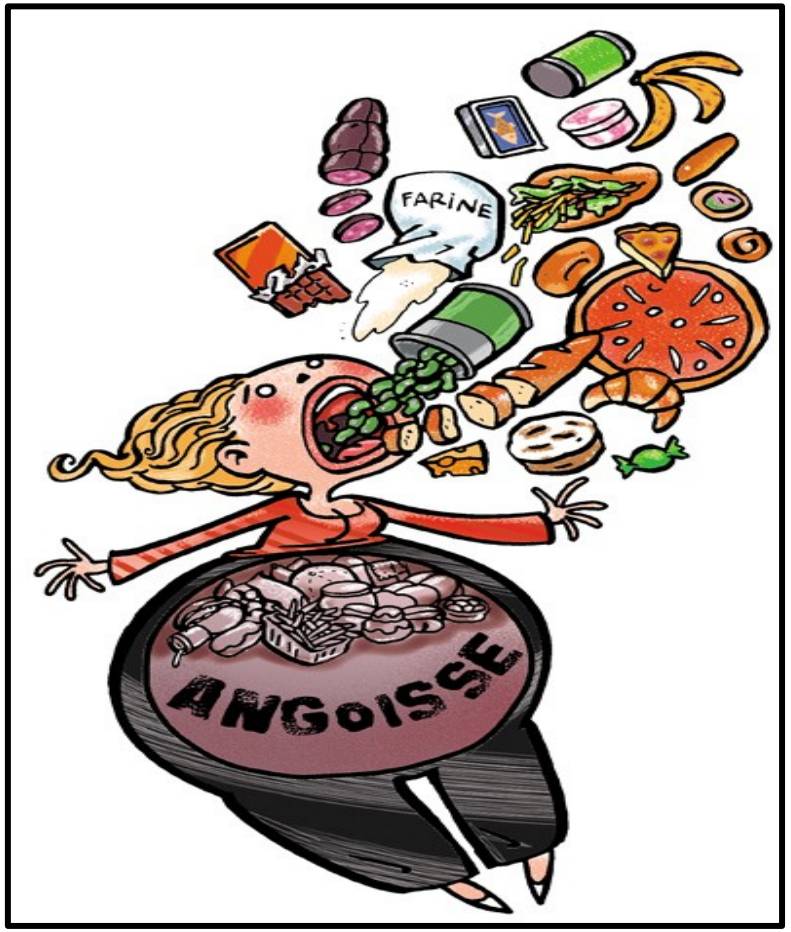
- Exemple : Consommation de gâteaux secs, de chocolat, de cacahouètes, etc…, lors des révisions d’un examen



4-L’enquête alimentaire

c. La boulimie:

- Se définit comme l’ingestion de grandes quantités d’aliments de toute nature, en dehors de toute faim
- Evoluant souvent par crise
- C’est est le plus souvent symptôme d’une décompensation psychiatrique.



5-Les dépenses énergétiques

- Dépendent de l’activité physique et intellectuelles et des conditions de l’ environnement.
- Importantes en cas d’activité manuelle (fellah) et sportive
- Diminuées en cas d’activité « sédentaire » (les fonctionnaires)
- Dans les pays dits du nord, il y a une grande consommation de matières grasses pour lutter contre le froid alors que l’activité est plutôt limitée.
- Dans les pays chauds, on assiste au phénomène inverse.

6-Le profil psychologique

- Il est important de déterminer le profil psychologique de l'individu obèse
- Rechercher des troubles du comportement: comme l'anxiété
- Des situations conflictuelles vécues par le patient
- Le retentissement psychologique de l'obésité

L’examen clinique:

Quatre objectifs fixés:

1. Mettre en évidence la surcharge pondérale

2. Déterminer le type d’obésité

3. Rechercher les signes d’accompagnement

4. Enfin dépister les complications

1-Mettre en évidence la surcharge pondérale

- La surcharge pondérale est déterminée par L'évaluation du poids du patient par la pesée



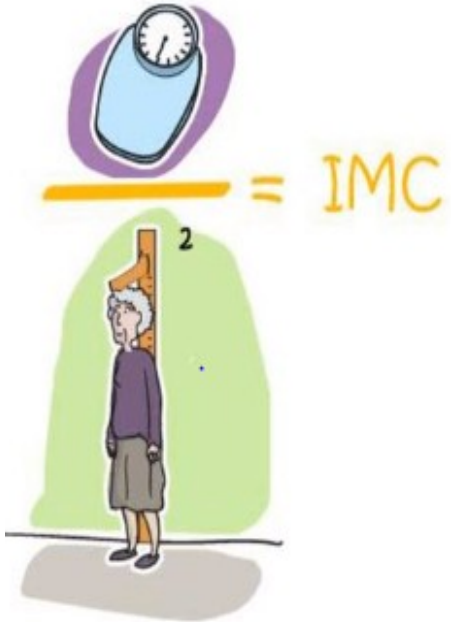
- Il existe généralement deux types d'obésité :

1. L'obésité modérée : excès de poids entre 20 et 50 % du poids théorique.
2. L'obésité sévère : excès de poids entre 50 et 200 % du poids théorique.



1-Mettre en évidence la surcharge pondérale

- L'importance de l'obésité est déterminée par l'index de la masse corporelle « IMC ou Body Mass Index ou BMI »
- **IMC = poids (kg) / taille² (m²)**



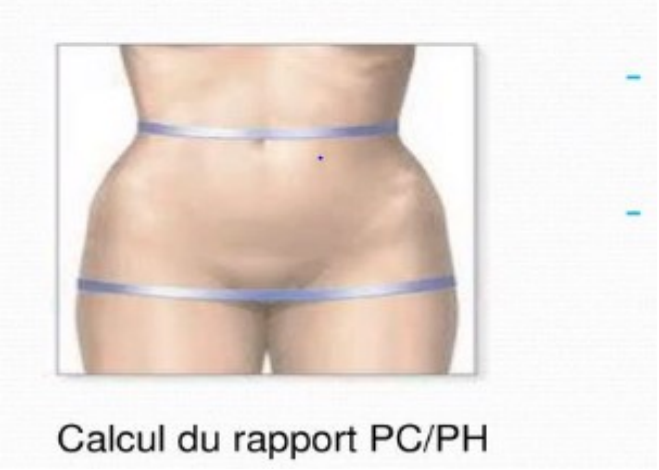
moins de 16,5	Dénutrition
16,5 à 18,5	Maigreur
18,5 à 25	Corpulence normale
25 à 30	Surpoids
30 à 35	Obésité modérée
35 à 40	Obésité sévère
plus de 40	Obésité morbide ou massive

2-Déterminer le type d'obésité

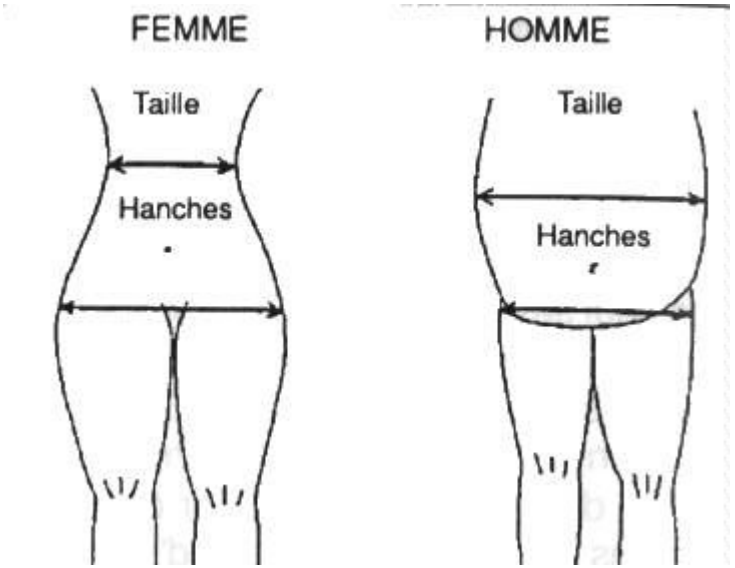
Se fait par l'appréciation de la répartition du tissu adipeux

a-Le rapport Taille / Hanche = RTH :

- C'est le rapport entre le plus petit périmètre situé entre l'ombilic et le bord inférieur des côtes et le plus grand périmètre en regard des grands trochanters sur le ligne du pubis.
- Normalement:
  - RTH < 0,8 chez la femme
  - RTH 0,95 à 1,00 chez l'homme



Calcul du rapport PC/PH



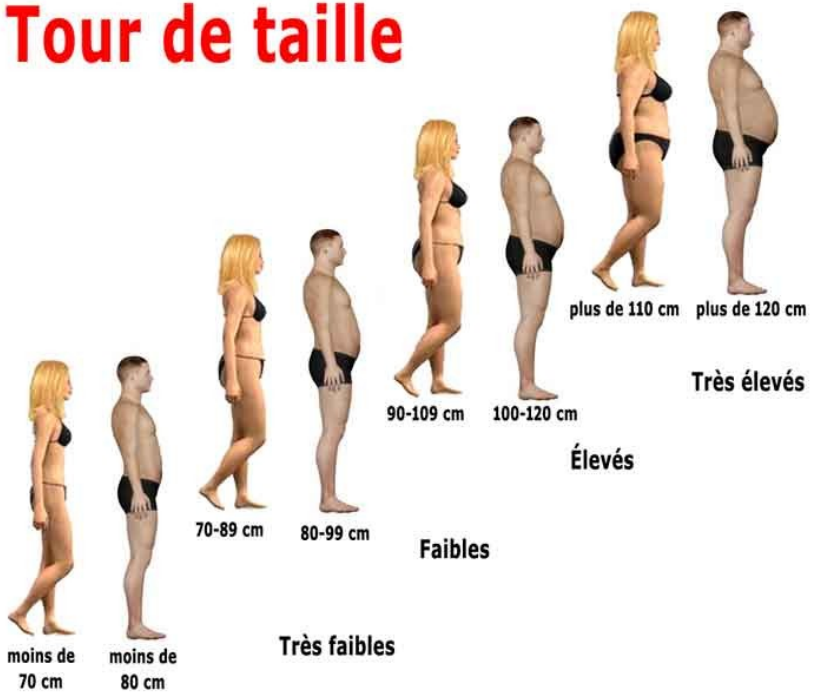
2-Déterminer le type d’obésité

b-Le tour de taille:

- Détermine le risque cardio-vasculaire chez le patient.
- Patient en position debout, les pieds joints, les bras relâchés le long du corps.



- Mètre-ruban à faire passer à mi-distance entre la dernière côte palpable et la crête iliaque



- Mesurer le tour de taille en fin d'expiration

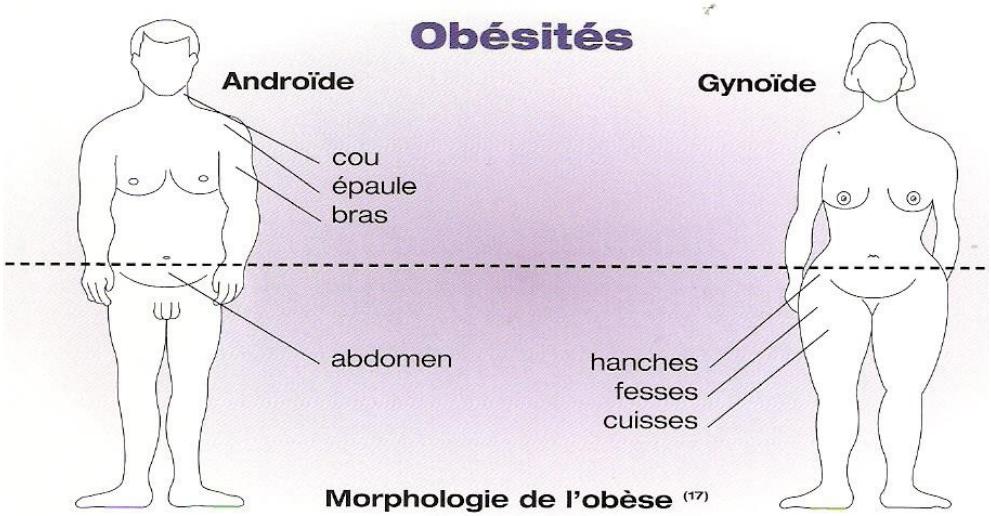
- Ne pas prendre la mesure sur des vêtements épais ou amples

2-Déterminer le type d’obésité

On distingue 4 types d’obésité:

1-L’obésité androïde:

- Obésité de type masculin
- Dite en forme de POMME
- Masse graisseuse prédominante à la partie supérieure du corps: abdomen sus ombilical, thorax, épaules, creux sus claviculaire
- La hanche n’est pas incluse
- Risque d’événement cardio vasculaires élevé

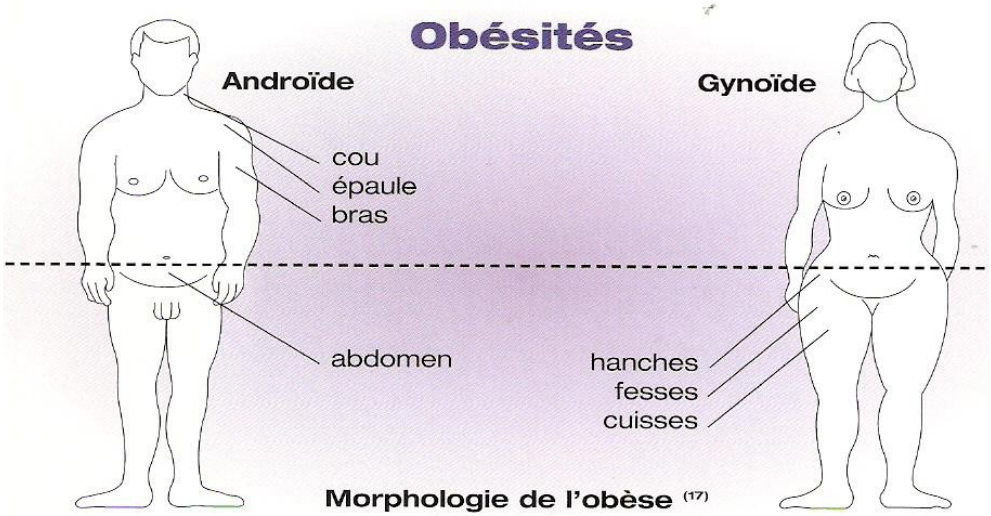




2-Déterminer le type d’obésité

2-L’obésité gynoïde

- Obésité de type féminin
- Dite obésité en POIRE
- La masse graisseuse prédominante au à la partie inférieure du corps à la hauteur des hanches: abdomen sous ombilical, fesses et cuisses
- Risque d’insuffisance veineuse







2-Déterminer le type d’obésité

3-L’obésité mixte:

- Obésité globale

- Rencontrée surtout dans les formes sévères des obésités

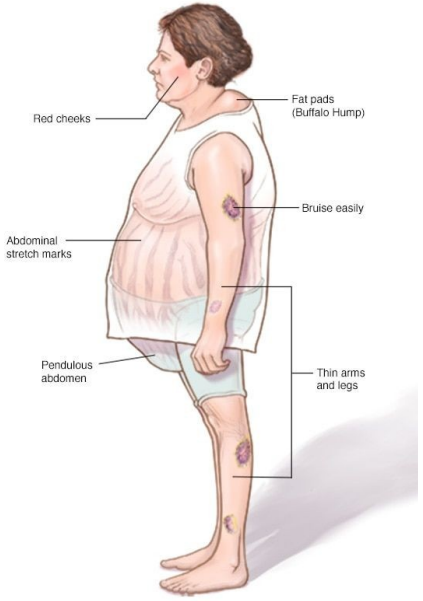


4-L’obésité cushingoïde

- Obésité particulière

- La masse graisseuse prédominante dans la région facio-tronculaire

- Elle se rencontre dans le syndrome de Cushing dû à un excès d’hormones corticostéroïdes.



3-Rechercher les signes d’accompagnement

- L’obésité se caractérise par la présence de signes accompagnateurs, surtout cutanés :

1-Les vergetures:

- Ce sont des stries ou lignes cutanées
- Plus ou moins longues
- De coloration blanchâtre: simple obésité
- Rougeâtre: syndrome de Cushing
- Qui prédominent surtout au niveau de l’abdomen, les cuisses et les seins
- Dues à la rupture des fibres élastiques du derme qui est sous tendu par l’épais pannicule adipeux





3-Rechercher les signes d’accompagnement

2-La cellulite:

- Il s’agit d’un épaississement de la peau
- Prend l’aspect « d’une peau d’orange »
- Prédomine surtout au niveau des hanches, les cuisses et les fesses
- Fréquente chez la femme





4- Dépister les complications:

- L’obésité est génératrice de nombreuses complications
- D’où sa gravité

1-des complications mécaniques: Arthrose du bassin, des genoux

2-Des complications respiratoires:

- Insuffisance respiratoire
- Syndrome d’apnée du sommeil: arrêt de flux aérien pendant au moins 10 secondes plus de 5 fois par heure

4- Dépister les complications:

3-complications cardio-vasculaires:

- Insuffisance coronaire.
- Hypertension artérielle
- Accident vasculaire cérébral
- Insuffisance veineuse

4-Des complications métaboliques:

- Diabète
- Dyslipidémie
- Goutte

4-Autres complications:

- Stéatose hépatique
- Mycose des gros plis
- Cancers : risque accru de cancer de la prostate et colorectal chez l'homme
- Cancer de l'endomètre, des voix biliaires, du col de l'utérus et du sein chez la femme
- Retentissement psycho social

La recherche étiologique:

- Sur le plan étiologique, il existe deux type d'obésité :

1-L'obésité constitutionnelle:

- C'est une obésité primitive ou essentielle
- En dehors d'une notion familiale, aucune cause particulière n'est retrouvée

2-L'obésité secondaire:

- Psychique: troubles du comportement et troubles psychiatriques
- Endocrinienne: syndrome de Cushing
- Neurologique: tumeurs cérébrales, lésions diencéphalique
- Médicamenteuse: prise de corticoïdes, de neuroleptiques, de la pilule

Amaigrissement

Définition

- C’une chute du poids due à une diminution de la masse active et de la masse adipeuse
- Témoin d’un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques ou conséquence d’une affection évolutive avec altération de l’état général en anorexie
- L’amaigrissement # « ***maigreur*** »
- La maigreur est une insuffisance pondérale non pathologique qui peut être constitutionnel et stable : poids insuffisant depuis l'enfance ou l'adolescence sans aucun trouble
- Définie par un IMC < 18
- IL faut distinguer la maigreur constitutionnelle de l’amaigrissement selon le poids de départ

Étude sémiologique

I- l’interrogatoire:

II-L’esxamen clinique

III-La recherche étiologique

L’interrogatoire

1-Étudier les caractéristiques sémiologiques:

- Le début
- Les circonstances de survenue
- Les facteurs déclenchant
- Son importance
- Son évolution

2-rechercher les signes accompagnateurs:

- Trouble de l’appétit:
  - Anorexie ou inappétence: perte de l’envie de manger
  - Polyphagie

- Signes digestifs ou généraux :
  - Des diarrhées subaiguës
  - Des vomissements
  - Une fièvre
  - Une asthénie…….

L’interrogatoire

3-L’ enquête alimentaire:

- Établir une relation entre la perte de poids et la réduction des apports énergétiques

- La persistance de l’appétit voire l’existence d’une hyperphagie, oriente vers une maigreur constitutionnelle ou une hyperthyroïdie

- L’anorexie élective à la viande évoque un processus néoplasique

- Une pseudo-anorexie avec refus actif de se nourrir est en faveur d’une anorexie mentale.

L’examen clinique:

Doit apprécier :

1-l’état de la peau:

- En général, amincie, sèche, squameuse

- Témoignant de l’état de dénutrition.

- Rechercher les vergetures, témoignant,

en cas d’obésité antérieure, de la fonte adipeuse.

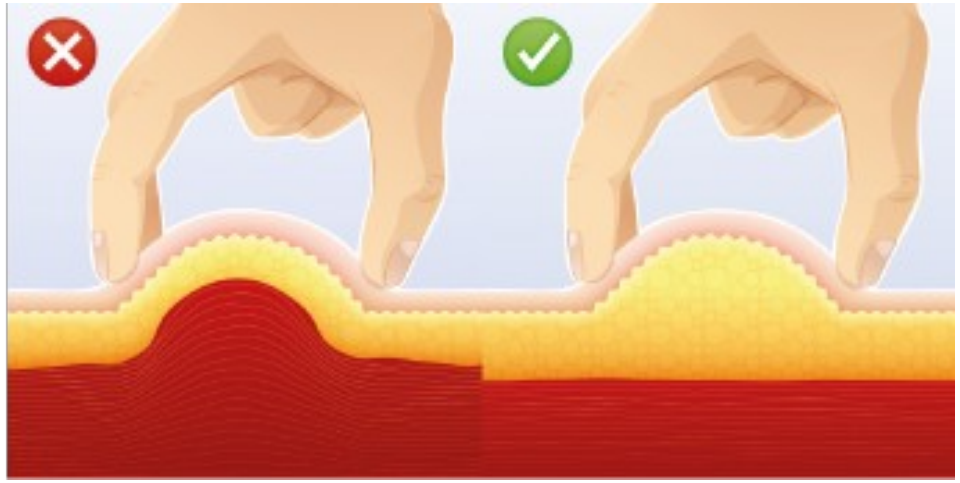


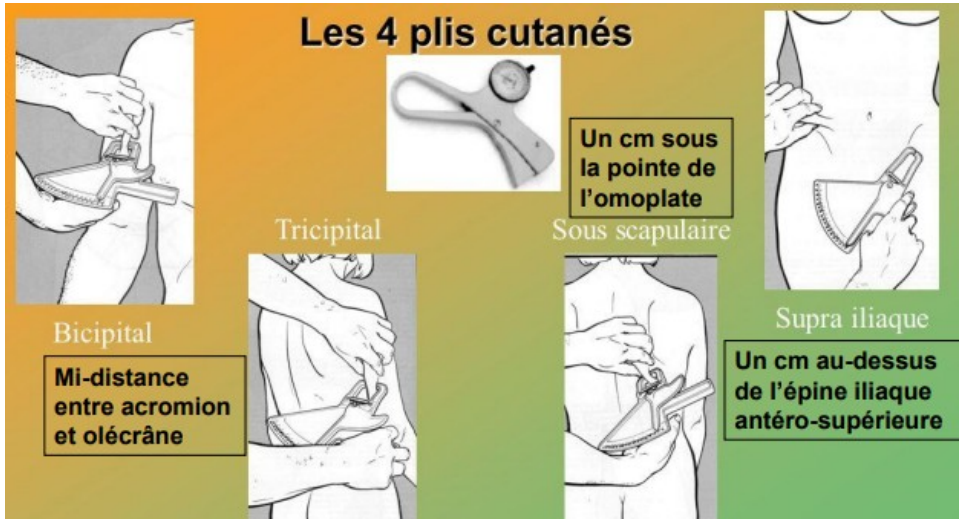


L’examen clinique:

<u>2-L’état du pannicule adipeux</u>:

- Aminci
- Son appréciation se fait surtout au niveau de 4 plis
- Se fait manuellement par pincement du pannicule entre l’index et le pouce ou à l’aide d’un pied à coulisse
- Les résultat seront comparés au résultat donné par les tables de DURNIN qui sont fonction de l’âge, sexe et taille





L’examen clinique:

3-L’état des muscles:

- Rechercher d’une fonte musculaire ou amyotrophie au niveau des membres
- La palpation des masses musculaires
- La mesure, à l’aide d’un mètre ruban, des diamètres des segments de membres (cuisses, bras, …)

4-L’état des phanères: En cas d’amaigrissement sévère prolongé:

- Des poils raréfiés et cassants.
- Des ongles striés et cassants



Les étiologies

1-Amaigrissement avec anorexie:

- Cause psychogène
  - Anorexie mentale
  - Dépression
- Cause digestive: Maladie ulcéreuse
- Maladies générales
  - Cancer
  - Tuberculose

Les étiologies

2-Amaigrissement sans anorexie:

En cas d'amaigrissement avec conservation de l'appétit et même parfois son exagération, il faut rechercher les causes suivantes :

- Un diabète de type 1
- Une hyperthyroïdie
- Une diarrhée chronique
- Une parasitose intestinale (ténia)